EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 89384
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-07-26 10:46:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIBEL DEL CARMEN OLAVE FUENTES			RUN	: 10.135.212-9
F.Nac	: 07-01-1966	Edad	: 58 AÑOS, 6 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: S.BOLIVAR 0523 LOS LIBERTADORES			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 96664605		
Fecha Ingreso	: 2024-07-19	Fecha Egreso	: 2024-07-26 10:46:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Insuficiencia Respiratoria Aguda Hipoxemica
- Edema pulmonar agudo resuelto
- Insuficiencia Cardíaca Descompensada
- Neumonia derecha en tratamiento
2. AKI KDIGO 2, no oligúrica/ ERC etapa 4.
-Hiperkalemia
3. DM2 mal controlada con complicaciones macro y microvasculares
- Retinopatía Diabética / Nefropatía Diabética / EAOC Amputación supracondilea izquierda
4. Vejiga neurogénica - Usuaria CUP permanente
5. HTA
6. Trastorno adaptativo

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I50.0-INSUFICIENCIA CARD?ACA CONGESTIVA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente conocida por la unidad, con antecedentes de HTA, DM2 IR con mal control metabólico, con múltiples complicaciones (retinopatia, nefropatia, EAOC con amputación supracondilea izquierda), derivada a servicio de urgencia desde unidad de rehabilitación de HSC el día 17/07/24 por cuadro de disnea de mínimos esfuerzos, según refiere de aproximadamente 5 días de evolución. Se toman exámenes de laboratorio, destaca Crea 2.9, PCR 72, GB 9700 GSA GSA pH : 7,41 pCO2 : 30 pO2 : 77 HCO3: 19; Rx de Tórax se aprecia foco de condensación derecho. Se hospitaliza para manejo de Neumonia, se inicia tratamiento con Ceftriaxona, sin embargo, paciente evoluciona con mayor requerimiento de FiO2 y peor gasometria, por lo que se solicita evaluación por Residente UTI. Al momento de la evaluación paciente apoyada con MV 50% saturando 90-92% sin uso de musculatura accesoria. Se decide ingreso, se apoya transitoriamente en Servicio de Urgencia con CNAF. Se solicita TC de tórax de alta resolución por Dimero D elevado el cual informa Signos sugerentes de edema pulmonar alvéolo intersticial. Derrame pleural bilateral. Cardiomegalia. Ateromatosis aortocoronaria.
Se ingresa para manejo y monitorización.
Paciente evoluciona hemodinamicamente con marcada hipertensión arterial, se apoya inicialmente con BIC de urapidil, por nula respuesta el 20/07/24 se reemplaza con BIC de NTG, que tras ajuste de antihipertensivos orales, se logra suspender el 22/07/24. Con tromboprofilaxis con HNF. Con anemia moderada desde su ingreso, sin criterios de transfusión. Ventilando espontáneo, se apoya inicialmente con CNAF, tras rescatar resultado de TC de Tórax se inicia soporte con VMNI con buena respuesta, se logra destete el 20/07/24, se mantiene apoyada con FiO2 por NRC 24%, Sin UMA.
Se mantiene afebril desde su ingreso, a su ingreso en servicio de urgencia se indica cobertura con Ceftriaxona,se decide escalar ATB a ampicilina/sulbactam. Panel viral negativo. Función renal comprometida, cursando AKI KDIGO 2, no oligúrica sobre ERC etapa 4, actualmente en vías de resolución. Actualmente sin trastorno HE, con aporte de K enteral. Metabolicamente estable, en tratamiento con INPH y refuerzo con IC segun esquema.
Paciente en condiciones de traslado a Sala Básica para continuar manejo.
durante estancia en servicio de medicina en buenas condiciones generales, eupneica, afebril.
Se toma eco abdominal que reporta normal. RX de tórax con franca mejoría en relación a controles previos.

Mantiene apoyo con KNT asociado a compromiso ventilatorio alcanzando destete de O2 con más de 24 horas sin complicaciones posteriores. Cumpliendo terapia ATB con ampicilina sulbactam durante 7 días.
Durante estancia, con episodio único obstructivo que requirió soporte temporal con O2 (aprox 1h), asociado a terapia broncodilatadora catalogado como crisis broncoespástica súbita.
Posterior a ello, con buena evolución clínica, con disminución de parámetros inflamatorios, sin episodios febriles o algún otro signo o síntoma asociado.
En vista de condiciones, se decide derivar a domicilio para continuidad de atención HODOM con KNT.

INDICACIONES AL ALTA

1. Régimen Diabetico hiposodico, restricción hidrica máximo 800 cc día
2. Omeprazol 20mg vo dia
3. Furosemida 40 mg vo dia
4. Amlodipino 10 mg al dia vo
5. Isosorbide 10 mg cada 8 horas VO
6. Hidralazina 100 mg cada 8 horas VO
7. Metildopa 250 mg c/6 hrs vo
8. Atorvastatina 20 mg al dia vo
9. Aspirina 100 mg al dia vo
10. Cilostazol 100 mg c/12 hrs vo
11. Sertralina 100 mg por la mañana vo
12. Quetiapina 25 mg noche vo SOS
13. Trazodona 50 mg dia vo (23 hrs)
14. Pregabalina 75 mg c/12 hrs vo
15. Paracetamol 1 gr c/8 hrs vo SOS
16. B ipratropio 4 puff c6h
17. Insulina NPH 18 Unidades am (7:00 hr) - 6 Unidades noche (22:00 hrs) sc
18. KNT Respiratoria - Motora interdiario
19. Control ex lab 48hrs: supervisar función renal
20. Control poli medicina interna <30 días

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO